

Modele STPP

STPP to rodzina, nie jeden model. Warianty różnią się intensywnością, fokusem i techniką. Model to pryzmat, przez który patrzysz na ten sam materiał — dobierasz go do pacjenta.

CZAS: 30 min Szkolenie; wybór modelu dla konkretnego przypadku

ŹRÓDŁO: Leichsenring (2015); Abbass i in. (2014)

JAK UŻYWAĆ

Orientujesz się w sześciu głównych modelach STPP i dobierasz wariant do konkretnego pacjenta. Modele różnią się intensywnością pracy z obronami, rodzajem fokusu i tempem aktywacji afektu. W praktyce większość doświadczonych terapeutów stosuje **integrację** — np. DIT jako ramę, narzędzia ISTDP do pracy z obronami, AEDP do pracy z wczesnymi ranami.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Znajomość tylko jednego modelu albo mieszanie ich bez świadomości różnic ograniczają elastyczność. Każdy model to **pryzmat** na ten sam materiał, z innymi akcentami: ISTDP dla silnych obron, terapia fobii afektu dla dystansu do emocji, AEDP dla traumy relacyjnej. Dobór według profilu pacjenta i własnego szkolenia zwiększa szansę skuteczności, zwłaszcza u pacjentów „nieodpowiadających” na jeden model.

01



Sześć głównych modeli

ISTDP	Davanloo / Abbass	najbardziej aktywny; konfrontacja obron; „odblokowanie nieświadomego”
Tavistock	Malan	interpretacja; dwa trójkąty (konfliktu i osób)
APT	McCullough	terapia fobii afektu; desensytyzacja uczuć jak w ekspozycji
CCRT-SE	Luborsky	wspierająco-ekspresyjna; rdzeniowy temat konfliktu relacyjnego
DIT	Lemma / Fonagy	16 sesji; depresja; rekomendowana w wytycznych NICE
AEDP	Fosha	przyspieszona; oparta na więzi; afekt transformujący

02 Dopasowanie modelu do problemu

Depresja umiarkowana → **DIT**

Powtarzalne wzorce relacyjne → **TLDP / CCRT-SE**

Trauma relacyjna → **AEDP**

Somatyzacja / lęk → **ISTDP**

Dystans do emocji (aleksytymia) → **APT**

Kryzys straty / separacji → **Mann**

03 Wybór dla tego pacjenta

Rozważ profil pacjenta i własne kompetencje. Zapisz model wiodący oraz narzędzia z innych modeli, które chcesz zintegrować.

MODEL WIODĄCY

NARZĘDZIA Z INNYCH MODELI

04 Uzasadnienie doboru

Zapisz, dlaczego ten model pasuje do tego pacjenta — to porządkuje conceptualizację i ułatwia superwizję.

DLACZEGO TEN MODEL

Klucz: nie traktuj modeli jako wzajemnie wykluczających się. Model to pryzmat, przez który patrzysz na ten sam materiał. Wybieraj ten, który najlepiej pasuje do konkretnego pacjenta i Twojego szkolenia — a w praktyce integruj narzędzia z kilku.